

Показания к проведению основных манипуляций

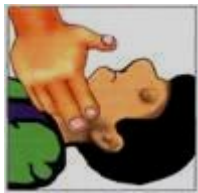
Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по груди и приступить к сердечно-легочной реанимации	1. Нет сознания 2. Нет реакции зрачков на свет 3. Нет пульса на сонной артерии
Когда следует накладывать давящие повязки	1. При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны 2. Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания*
Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут	1. Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 2. Над раной образуется валик из вытекающей крови 3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего
Когда необходимо накладывать защитные жгуты	В случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей
Когда необходимо накладывать шины на конечности	1. Видны костные отломки 2. При жалобах на боль 3. При деформации и отеках конечностей 4. После освобождения придавленных конечностей 5. При укусах ядовитых змей

* Синдром сдавливания - тяжёлое патологическое состояние, возникающее в результате закрытого повреждения больших участков мягких тканей под влиянием большой и иногда длительно действующей механической силы.

Оказание первой помощи пострадавшему при различных видах поражений

Внезапная смерть (если нет сознания и нет пульса на сонной артерии)

1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной
артерии



НЕЛЬЗЯ! Терять время на определение
признаков дыхания

Освободить грудную клетку от одежды и
расстегнуть поясной ремень



НЕЛЬЗЯ! Наносить удар по груди и проводить
непрямой массаж сердца, не освободив грудную
клетку и не расстегнув поясной ремень

1. Прикрыть двумя пальцами мечевидный
отросток



НЕЛЬЗЯ! Наносить удар по мечевидному
отростку или в область ключиц

4. Нанести удар кулаком по груди



НЕЛЬЗЯ! Наносить удар при наличии пульса на
сонной артерии

5. Начать непрямой массаж сердца



Глубина продавливания грудной клетки должна
быть не менее 3-4 см.

НЕЛЬЗЯ! Располагать ладонь на груди так,
чтобы большой палец был направлен на
спасателя

Сделать «вдох» искусственного дыхания



Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть
голову пострадавшего и сделать максимальный
выдох ему в рот.

НЕЛЬЗЯ! Сделать «вдох» искусственного дыхания
не зажав предварительно нос пострадавшего

Выполнять комплекс реанимации При сужении зрачков, но отсутствии сердцебиения реанимацию нужно проводить до прибытия медперсонала	Правила выполнения Если оказывает помощь один спасатель, то 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину. - Если оказывает помощь группа спасателей, то 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину. - Для быстрого возврата крови к сердцу - приподнять ноги пострадавшего. - Для сохранения жизни головного мозга - приложить холод к голове. - Для удаления воздуха из желудка - повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка.
Организовать действия партнеров  НЕЛЬЗЯ! Располагаться спасателям друг напротив друга и обходить партнера сзади	ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ проводит непрямой массаж сердца, отдает команду «Вдох!» и контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки. ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ проводит искусственное дыхание, контролирует реакцию зрачков, пульс на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии пострадавшего: «Есть реакция зрачков! Нет пульса. Есть пульс!» и т. п. ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ приподнимает ноги пострадавшего для лучшего притока крови к сердцу и готовится к смене партнера, выполняющего непрямой массаж сердца

Особенности реанимации в ограниченном пространстве

1. Нанести удар кулаком по груди



Удар можно наносить в положении пострадавшего «сидя» и «лежа»

2. Уложить пострадавшего на спину



Комплекс реанимации можно проводить только в положении пострадавшего «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности

Состояние комы (если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии)

1. Повернуть пострадавшего на живот

Только в положении «лежа на животе» пострадавший должен ожидать прибытия врачей



НЕЛЬЗЯ! Оставлять человека в состоянии комы лежать на спине

2. Удалить слизь и содержимое желудка



Периодически удалять из ротовой полости слизь и содержимое желудка с помощью стерильной салфетки.

3. Приложить к голове холод



Можно использовать пузырь со льдом или бутылки и пакеты с холодной водой или снегом, либо гипотермический пакет

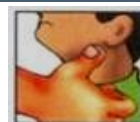
Артериальное кровотечение

1. Прижать пальцами или кулаком артерию в указанных точках



До наложения жгута поврежденную конечность следует оставить в приподнятом положении.

На конечностях точка прижатия артерии должна быть выше места кровотечения. На шее и голове - ниже раны или в ране.



Прижатие сонной артерии в ране или ниже раны



Временная остановка артериального кровотечения из ран ладони



Прижатие плечевой артерии выше раны

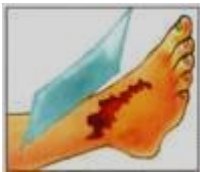


Прижатие кулаком бедренной артерии

НЕЛЬЗЯ! Терять время на освобождение конечностей от одежды

2. Наложить кровоостанавливающий жгут (предпочтительно жгут «альфа»)					
					
1. Завести жгут за конечность и растянуть с максимальным усилием	2. Прижать первый виток жгута и убедиться в отсутствии пульса	3. Наложить следующие витки жгута с меньшим усилием	4. Обернуть петлю задвижку вокруг жгута	5. Оттянуть петлю и завести под свободный конец жгута	6. Вложить записку о времени наложения жгута под резинку петли
Жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час. В случаях посинения и отека конечности (при неправильном наложении жгута) следует немедленно заново наложить жгут.					

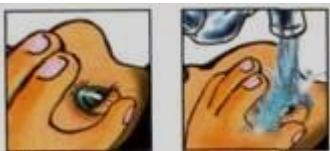
Ранение конечности, как накладывать повязки на раны

1. Накрыть рану стерильной салфеткой, полностью прикрыв края раны	2. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем
	
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Промывать рану водой	ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Вливать в рану спиртовые или любые другие растворы

Термические ожоги

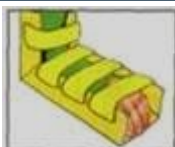
Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей Поставить под струю холодной воды на 10-15 минут и/или приложить холод на 20-30 минут  НЕЛЬЗЯ! Смазывать обожженную поверхность маслами и жирами	Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи 1. Накрыть сухой чистой тканью 2. Поверх сухой ткани приложить холод   ЗАПРЕЩАЕТСЯ!: - Промывать водой - Бинтовать обожженную поверхность
--	--

Травмы глаз

Раны глаз или век	Ожоги глаз или век в случаях попадания едких химических веществ
Накрыть глаз стерильной салфеткой Все операции проводить в положении пострадавшего «лежа»  Зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движений глазных яблок  НЕЛЬЗЯ! Промывать водой колотые и резаные раны глаз и век	1. Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды  2. Промыть глаз под струей холодной воды так, чтобы она стекла от носа кнаружи НЕДОПУСТИМО! применять нейтрализующую жидкость при попадании в глаза едких веществ (кислота-щелочь)

Переломы костей конечностей

Зафиксировать конечность с помощью складных	Зафиксировать конечность с
---	----------------------------

шин		помощью подручных средств
 Фиксирование костей предплечья и локтевого сустава	Фиксирование костей голени, коленного и голеностопного суставов 	
При открытых переломах сначала наложить повязку и только затем - шину НЕЛЬЗЯ! Использовать шины, если пострадавший лежит в позе «лягушки» 		

Первая помощь в случаях поражения электрическим током

Правила освобождения от действия электрического тока НЕДОПУСТИМО! Прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания Обесточить пострадавшего (не забывая о собственной безопасности!). При отсутствии пульса на сонной артерии — нанести удар кулаком по груди и приступить к реанимации. При коме — повернуть на живот. При электрических ожогах и ранах — наложить повязки. При переломах костей конечностей — шины. Вызвать «Скорую помощь».	
Освобождение пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В следует: 1. Надеть диэлектрические перчатки. 2. Отключить электрооборудование; 3. Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами; 4. Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.	Правила эвакуации пострадавшего из зоны действия электрического тока: 1. Во избежание поражения током за пострадавшего следует браться только одной рукой и только за сухую одежду. 2. Под ЛЭП пострадавшего следует оттащить не менее чем на 8 метров от лежащего на земле провода; 3. В помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 метра

5. Если в пределах видимости находятся все необходимые средства защиты, обязательно воспользоваться ими. 6. Только в крайнем случае можно ограничиться лишь одним из перечисленных выше действий (кроме п. 4.) НЕЛЬЗЯ! Приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока ПОМНИТЕ О СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! Нельзя брать за мокрую одежду или открытые участки тела пострадавшего	от источника тока. 
--	---

Правила перемещения в зоне «шагового» напряжения

 НЕЛЬЗЯ! Отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие шаги	В радиусе 8 метров от места касания земли электрическим проводом можно попасть под «шаговое» напряжение. Передвигаться в зоне «шагового» напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах либо «гусиным шагом» — пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. НЕЛЬЗЯ! Приближаться бегом к лежащему проводу
--	--

Падение с высоты, что делать в случаях падения с высоты при сохранении сознания

1. Оценить состояние пострадавшего

Вынужденная поза «лягушки» — это верный признак крайне опасных повреждений. Пострадавший не может изменить положение ног.  Стопы развернуты наружу, колени приподняты и разведены	К таким повреждениям относятся: - переломы костей таза и повреждения тазобедренных суставов; - переломы бедренных костей; - повреждения позвоночника; - разрывы внутренних органов и внутренние кровотечения НЕЛЬЗЯ! Перемещать пострадавшего, снимать с него одежду или позволять ему шевелиться
---	---

Обморок, схема действий в случаях обморока

1  Убедиться в наличии пульса на сонной артерии	2  Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень	Если нет пульса на сонной артерии - приступить к комплексу реанимации. Если есть пульс на сонной артерии - приподнять ноги, расстегнуть ворот сорочки, ослабить галстук и поясной ремень. Надавить на болевую точку Если в течение 3 минут сознание не появилось - повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове.
3  Приподнять ноги	4  Надавить на болевую точку	При появлении боли в животе или повторных обмороков - положить холод на живот При тепловом ударе - перенести в прохладное место, приложить холод к голове и груди
НЕДОПУСТИМО! - Прикладывать грелку к животу или пояснице при болях в животе или повторных обмороках; - Кормить в случаях голодного обморока.		В случаях голодного обморока - напоить сладким чаем. Во всех случаях обморока необходимо вызвать врача!